

CLUB ATLÉTICO DEPORTIVO RIESTRA

Categoría 2016 · Fútbol Infantil

INFORME DE SEGUIMIENTO ANTROPOMÉTRICO Y MADURATIVO

Comparativo Febrero → Junio 2026

Lic. Leandro Santagada

Nutricionista Deportivo · ISAK Nivel 2 Antropometrista

Buenos Aires, junio de 2026

1. Introducción y objetivo del informe

Este informe resume la evolución física del plantel de la Categoría 2016 entre dos rondas de evaluación antropométrica: la medición basal de febrero de 2026 y la medición de seguimiento de junio de 2026, separadas por aproximadamente 4 meses.

El objetivo no es comparar a los chicos entre sí ni etiquetarlos con una sola medición, sino acompañar la forma en que cada uno crece, detectar a tiempo cualquier desvío que merezca atención nutricional o médica, y dar al cuerpo técnico información útil para planificar cargas de entrenamiento de forma acorde a la maduración real de cada chico, no solo a su edad de carnet.

En números

Plantel evaluado en junio: 35 jugadores.

Jugadores con ambas mediciones (comparable): 29 jugadores.

Jugadores nuevos en junio (solo medición de junio): 6 jugadores.

Dato pendiente: 1 jugador (Sebastian Gomez, ausente en junio).

2. Cómo leer este informe

Para que el informe sea útil más allá del consultorio, estos son los tres conceptos que se repiten a lo largo del documento, explicados en términos simples:

Percentilo de talla y de peso

Comparamos la talla y el peso de cada chico con los de miles de niños de su misma edad y sexo (tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría / WHO 2007). El percentilo indica qué posición ocupa dentro de ese grupo: un chico en el percentilo 70 es más alto que el 70 % de los chicos de su edad. Entre percentilo 10 y 90 se considera un rango esperable; por debajo de 10 o por encima de 90 amerita seguimiento más cercano (no significa que haya un problema, sino que vale la pena observarlo en el tiempo).

IMC (Índice de Masa Corporal)

Es el peso dividido por la altura al cuadrado. En niños, igual que con la talla, se interpreta según percentilos para la edad (no con los mismos valores fijos que en adultos). Lo clasificamos en cuatro categorías: bajo peso ($< P5$), adecuado ($P5-P85$), sobrepeso ($P85-P95$) y obesidad ($\geq P95$).

PHV — Pico de Velocidad de Crecimiento

Es la edad estimada en la que cada chico atravesará su mayor "estirón" puberal. Se calcula con la ecuación validada de Mirwald (2002) a partir de la talla, el peso y la talla sentado. Es clave porque dos chicos de la misma edad cronológica pueden estar en momentos de maduración biológica muy distintos: eso explica gran parte de las diferencias de tamaño y fuerza que se ven en la cancha, y no debería usarse para descartar o sobrevalorar a un chico.

3. Resultados grupales: Febrero vs. Junio

El siguiente gráfico compara los promedios del plantel en ambas mediciones:

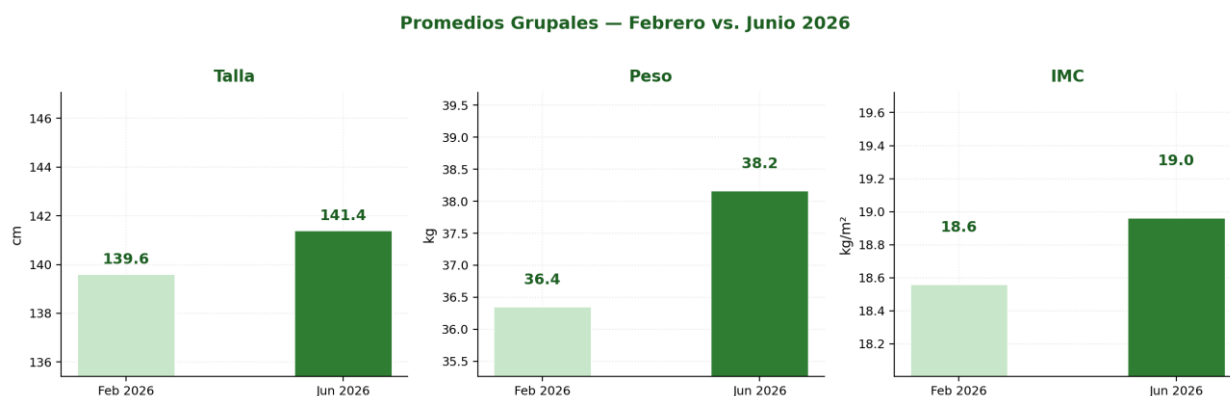


Gráfico 1. Promedios de talla, peso e IMC del plantel, febrero vs. junio 2026.

El plantel aumentó su talla promedio de 139,6 cm a 141,4 cm (+1,8 cm) y su peso promedio de 36,4 kg a 38,2 kg (+1,8 kg), lo que generó un leve aumento del IMC promedio de 18,6 a 19,0 kg/m². Los incrementos son consistentes con el crecimiento esperado para niños de 9–10 años.

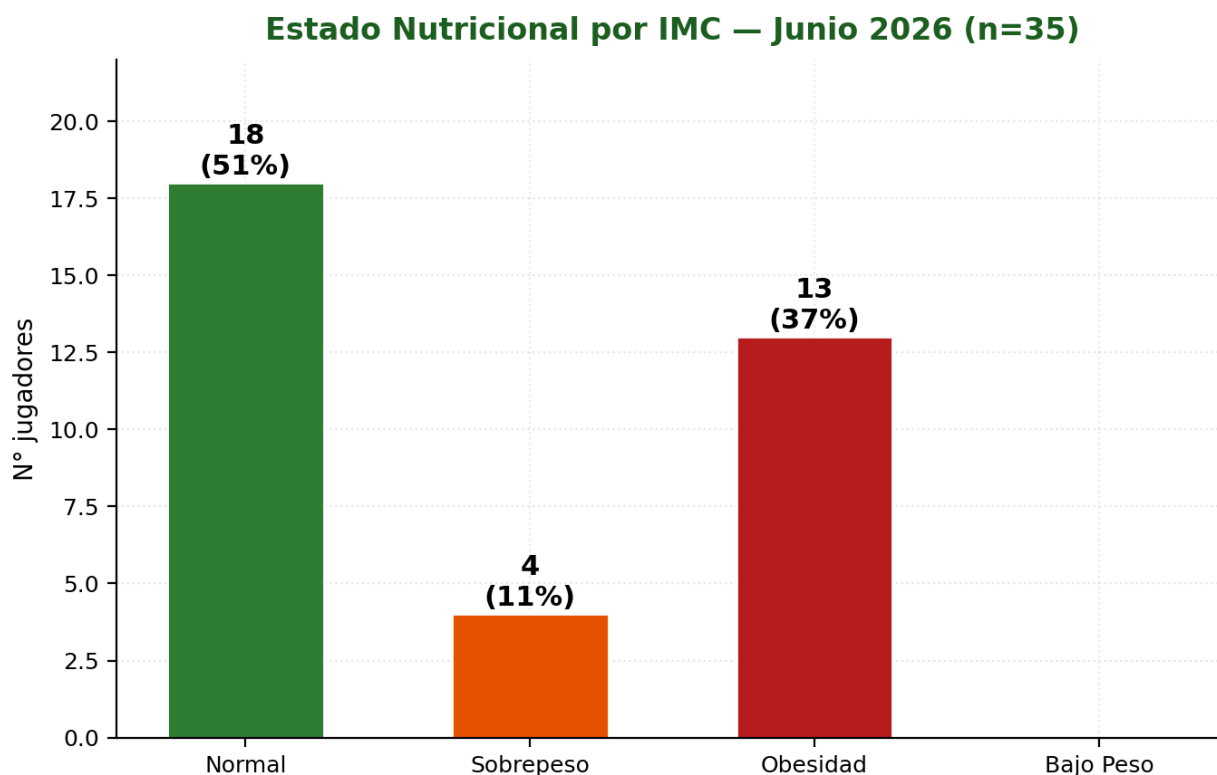


Gráfico 2. Distribución del plantel según estado nutricional (IMC), junio 2026.

Distribución de estado nutricional — Junio 2026:

- Adecuado (IMC P5–P85): 18 jugadores (51 %)
- Sobrepeso (IMC P85–P95): 4 jugadores (11 %)
- Obesidad (IMC > P95): 13 jugadores (37 %) — ver detalle en sección 7.
- Bajo peso: 0 jugadores.

El 48 % del plantel (17 de 35 jugadores) se ubica fuera del rango normal de IMC. Es la principal área de atención nutricional de este grupo.

4. Evolución individual de talla

Cada jugador creció de forma distinta en estos 4 meses. Para ese intervalo se espera una ganancia de entre 1,5 y 3,0 cm:

Variación Individual de Talla — Febrero → Junio 2026

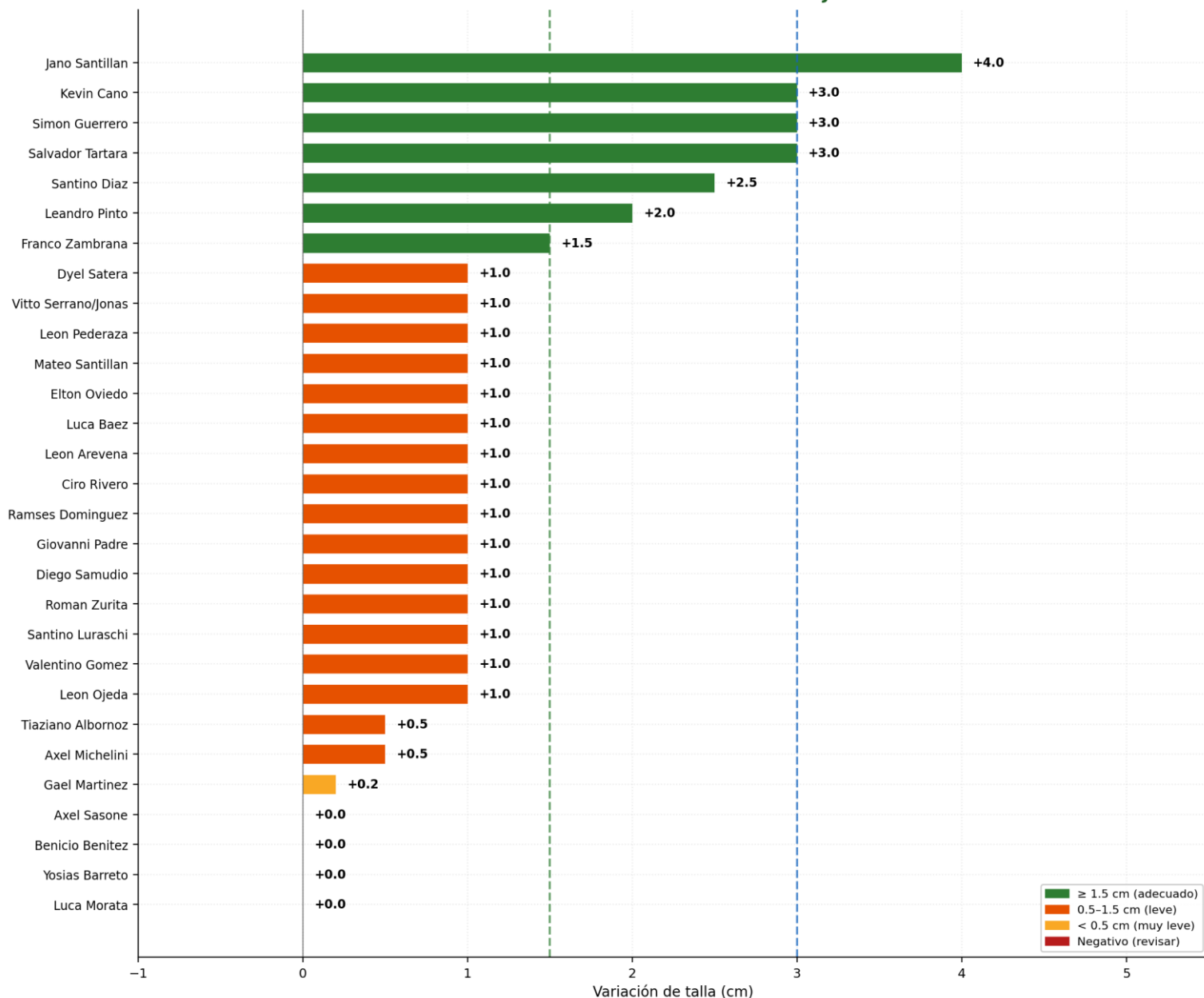


Gráfico 3. Variación individual de talla, febrero → junio 2026 (cm).

- 8 jugadores mostraron una ganancia igual o superior a 1,5 cm (rango adecuado), con Jano Santillan encabezando el grupo con +4,0 cm.
- 5 jugadores presentan 0,0 cm de variación (Luca Morata, Axel Sasone, Yosias Barreto, Benicio Benitez, Giovanni Padra), no es algo para alarmarse porque suele pasar, pero si habría que observar en la siguiente medición a ver que sucede.

5. Relación entre cambio de talla y cambio de peso

Este gráfico cruza cuánto cambió la talla versus cuánto cambió el peso en el mismo período. Sirve para identificar patrones: un jugador que sube de peso sin acompañarlo con talla amerita revisar hábitos alimentarios; uno que crece en talla y baja de peso puede estar en un brote de crecimiento que conviene sostener con mayor aporte calórico.

Variación de Talla vs. Variación de Peso — Feb → Jun 2026

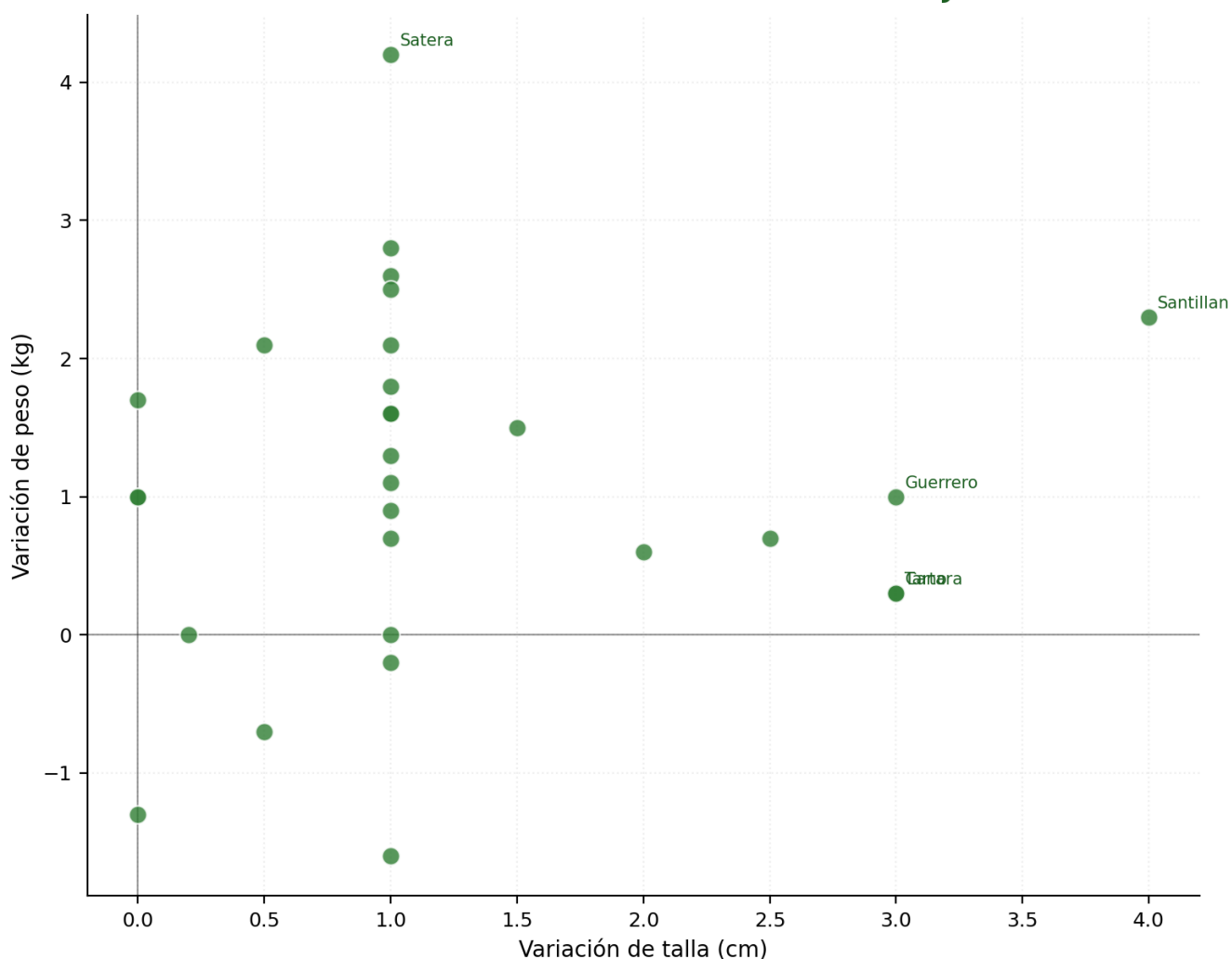


Gráfico 4. Variación de talla (cm) vs. variación de peso (kg), febrero → junio 2026.

La mayoría de los jugadores se ubica en el cuadrante superior derecho (aumento de talla y peso), patrón esperable en esta franja etaria previa al estirón puberal. Casos con descenso de peso (Elton Oviedo, Tiziano Albornoz, Ciro Rivero) conviene revisarlos individualmente (alimentación, contexto familiar, nivel de actividad fuera del club o por enfermedades).

6. Maduración biológica (PHV)

Se calculó la edad estimada de Pico de Velocidad de Crecimiento (PHV) para los 35 jugadores con datos completos de junio, usando la ecuación de Mirwald et al. (2002). Todos los jugadores se encuentran en etapa pre-PHV, como es esperable a los 9–10 años de edad.

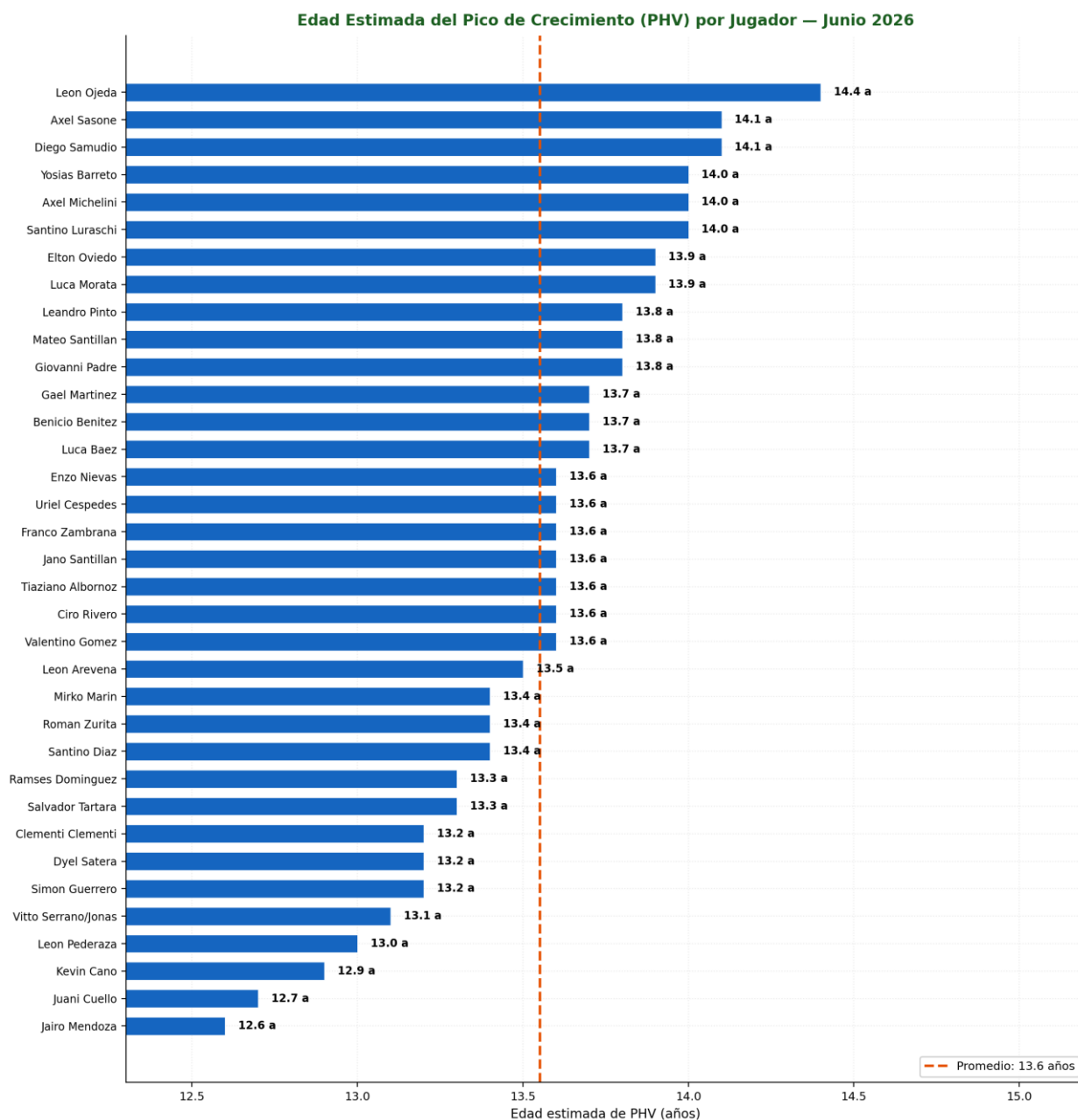


Gráfico 5. Edad estimada de PHV por jugador (años). Promedio del plantel: 13,6 años.

7. IMC por jugador — Junio 2026

El siguiente gráfico muestra el IMC de cada jugador con líneas de referencia que indican el inicio del sobrepeso (~P85) y la obesidad (~P95) para la edad promedio del plantel (10 años):

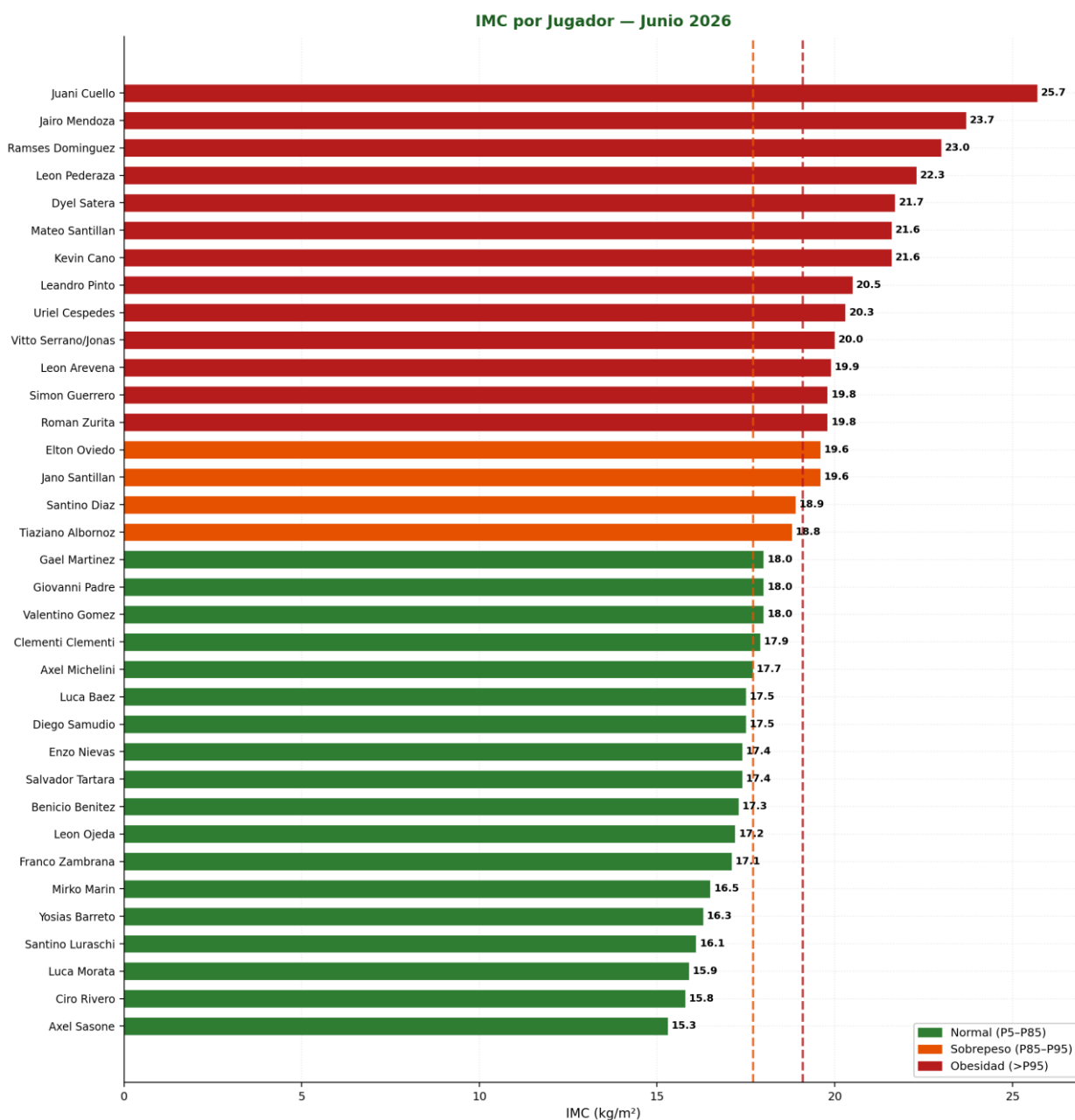


Gráfico 6. IMC por jugador con líneas de referencia P85 y P95 — Junio 2026. Verde = adecuado; naranja = sobrepeso; rojo = obesidad.

8. Talla por jugador — Junio 2026

El gráfico siguiente muestra la talla de cada jugador junto con las líneas de percentilo de referencia para varones de 10 años (SAP/WHO 2007):

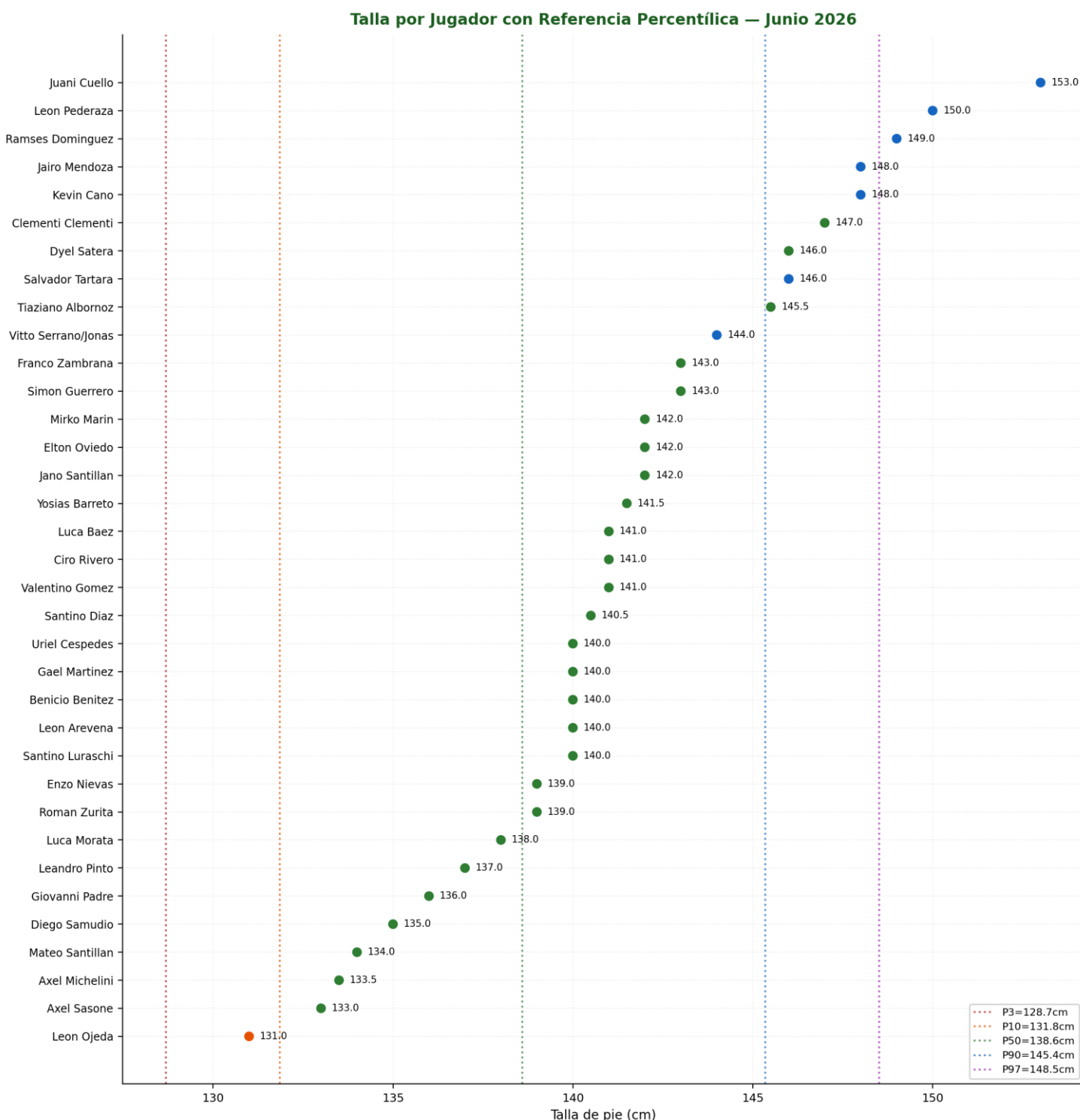


Gráfico 7. Talla por jugador con líneas de percentilo — Junio 2026. Naranja = P3–P10; verde = normal (P10–P90); azul = talla alta (>P90).

9. Percentil de peso-para-edad — Junio 2026

El percentil de peso-para-edad indica cómo se ubica el peso de cada jugador respecto a niños de su misma edad y sexo. Debe interpretarse siempre en conjunto con el IMC: un jugador alto naturalmente pesará más y tendrá un percentil de peso elevado aunque su composición corporal sea saludable.

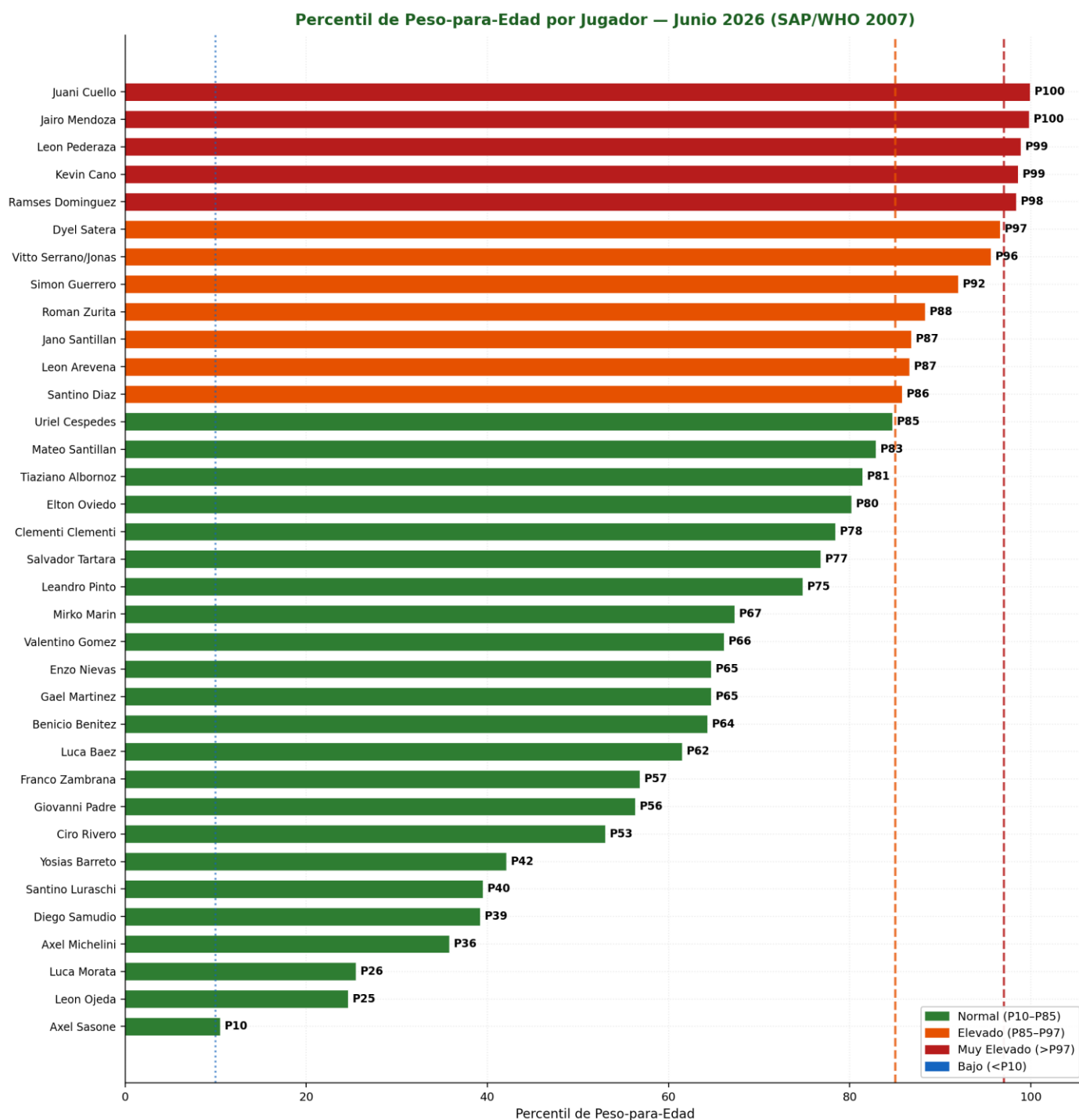


Gráfico 8. Percentil de peso-para-edad por jugador — Junio 2026 (SAP/WHO 2007). Naranja = elevado (P85–P97); rojo = muy elevado (>P97).

Resumen de percentil de peso:

- Normal (P10–P85): 23 jugadores.

- Elevado (P85–P97): 7 jugadores — Santino Diaz, Roman Zurita, Simon Guerrero, Leon Arevena, Jano Santillan, Vitto Serrano, Dyel Satera.

- **Muy Elevado (>P97): 5 jugadores — Ramses Dominguez, Kevin Cano, Leon Pederaza, Juani Cuello, Jairo Mendoza.**

- Bajo (<P10): 0 jugadores.

Los 5 jugadores con peso Muy Elevado también presentan IMC en zona de obesidad, confirmando la necesidad de intervención nutricional prioritaria en esos casos.

10. Casos a destacar y seguimiento individual

Talla baja para la edad (percentilo < 10)

El siguiente jugador presenta una talla inferior al percentilo 10. Se recomienda derivación pediátrica para descartar causas nutricionales o médicas:

- Leon Ojeda — talla 131 cm · percentilo 5

Talla alta para la edad (percentilo > 90)

Estos jugadores presentan una talla por encima del percentilo 90. No representa un problema clínico; es una característica favorable en el contexto del fútbol:

- Kevin Cano — 148 cm · percentilo 96
- Juani Cuello — 153 cm · percentilo 99
- Jairo Mendoza — 148 cm · percentilo 98
- Leon Pederaza — 150 cm · percentilo 97
- Ramses Dominguez — 149 cm · percentilo 92
- Vitto Serrano/Jonas — 144 cm · percentilo 91
- Salvador Tartara — 146 cm · percentilo 90

IMC en zona de obesidad (percentilo ≥ 95)

Estos 13 jugadores presentan IMC por encima del percentilo 95. Se recomienda intervención nutricional individual, enfocada en educación alimentaria, hábitos y contexto familiar. El enfoque debe ser positivo, gradual y sin estigmatizar al jugador:

- Juani Cuello — IMC 25.7 kg/m² · percentilo 100
- Jairo Mendoza — IMC 23.7 kg/m² · percentilo 100
- Ramses Dominguez — IMC 23.0 kg/m² · percentilo 99
- Leon Pederaza — IMC 22.3 kg/m² · percentilo 99
- Kevin Cano — IMC 21.6 kg/m² · percentilo 99
- Mateo Santillan — IMC 21.6 kg/m² · percentilo 99
- Dyel Satera — IMC 21.7 kg/m² · percentilo 99
- Vitto Serrano/Jonas — IMC 20.0 kg/m² · percentilo 97
- Roman Zurita — IMC 19.8 kg/m² · percentilo 96
- Uriel Cespedes — IMC 20.3 kg/m² · percentilo 96
- Leandro Pinto — IMC 20.5 kg/m² · percentilo 96
- Simon Guerrero — IMC 19.8 kg/m² · percentilo 96
- Leon Arevena — IMC 19.9 kg/m² · percentilo 96

IMC en zona de sobrepeso (percentilo 85–95)

- Jano Santillan — IMC 19.6 kg/m² · percentilo 94
- Elton Oviedo — IMC 19.6 kg/m² · percentilo 93
- Santino Diaz — IMC 18.9 kg/m² · percentilo 92
- Tiaziano Albornoz — IMC 18.8 kg/m² · percentilo 88

11. Limitaciones del informe

- 6 jugadores solo tienen medición de junio (sin basal de febrero), por lo que no fue posible calcular su evolución en este período.
- Un intervalo de 4 meses es corto para sacar conclusiones definitivas sobre velocidad de crecimiento individual; estos resultados deben interpretarse como una fotografía comparativa, a confirmar con próximas rondas.
- La edad estimada de PHV tiene un error esperable de $\pm 0,5$ a 0,6 años (Mirwald et al., 2002); no reemplaza una evaluación médica de maduración si se requiriese mayor precisión clínica.

12. Conclusiones y recomendaciones

- El plantel muestra un crecimiento dentro de parámetros esperables (+1,8 cm de talla y +1,8 kg de peso en 4 meses).
- El estado nutricional es la principal área de atención: el 48 % del plantel (17 de 35) presenta sobrepeso u obesidad según IMC. Se recomienda abordar esto con estrategias educativas grupales e intervenciones individuales para los casos más graves, siempre con enfoque positivo y con participación familiar.
- Todos los jugadores se encuentran en etapa pre-PHV, con pico de crecimiento estimado entre los 12,6 y 14,4 años. **Es el momento ideal para trabajar habilidades técnicas y coordinación.**
- Completar el dato de Sebastian Gomez cuando retome la actividad.
- Próxima evaluación sugerida: en 4–6 meses, con protocolo unificado (mismo instrumento y observador)

Elaborado por Lic. Leandro Santagada — Nutricionista Deportivo | ISAK Nivel 2 Antropometrista | Deportivo Riestra | Junio 2026